EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 73329
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2023-10-31 12:42:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: HERNAN AMALIO PICEROS ALARCON			RUN	: 7.641.898-5
F.Nac	: 29-10-1956	Edad	: 67 AÑOS	Género	: Masculino
Dirección	: AGUA BUENA ARRIBA			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA B	Teléfono	: 56802747		
Fecha Ingreso	: 2023-10-28	Fecha Egreso	: 2023-10-31 12:42:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. I64.X-ACCIDENTE VASCULAR ENCEFALICO AGUDO NO ESPECIF.COMO HEMORRAG

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

- ACV periventricular izquierdo subagudo. ATE
- Ateromatosis intracraneana, estenosis suboclusiva ACM izquierda.
- Taquiarritmias supraventricular. TSV por reentrada vs FA paroxistica
- Traqueobronquitis
- Antecedentes:

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. I64-ACCIDENTE VASCULAR ENCEFALICO AGUDO, NO ESP.COMO HEMORRAGICO (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Antecedentes:
- Hipertensión arterial
- Diabetes mellitus tipo 2 IR
- ACV antiguo 2015
- Artrosis
- Cardiopata coronario
- Hipoacusia usuario de audífono

Diestro mRS 3
Paciente con antecedente de secuela por evento cerebrovascular en 2015. Consultó el 13/10/23 por alteración del lenguaje, alteración de la marcha por debilidad de hemicuerpo derecho, al examen neurológico en ese entonces se describe disartria, nominación repetición y comprensión normal, debilidad derecha no cuantificada. Se realizó un TC de encéfalo sin contraste en que se describe ausencia de lesiones agudas. Se indicó alta por médico de SU.
Reconsulta en SU de HSC derivado desde APS el 26/10/23 por disnea, tos con expectoración. Al ingreso con FC 90 lpm, PA 138/83 mmHg, T° 36.4°C, Sat 96%, HGT 110 mg/dL, al examen se describe alteración lenguaje y debilidad de HC derecho. Al Se realizó estudio complementario con laboratorio sin alteraciones de relevancia y angioTC de cerebro y cuello en que se constata intensa microangiopatía, con lesión secuelar corona radiada derecha antigua, territorio lenticulo-estriada derecha. Hipodensidad de aspecto reciente periventricular izquierdo. En fase angiográfica con ateromatosis intracraneana difusa, estenosis suboclusiva de segmento M1 izquierdo y oclusivo posterior derecha. Con estenosis significativa bulbo carotideo derecho. Se decidió hospitalizar para tratamiento y rehabilitación. Evaluado por fonoaudiología con plan de régimen mixto (papilla por via oral por fono y liqudos por SNG. En monitorización con salvas de taquiarritmia supraventricular regular de alta frecuencia sospechosa de episodios de TSV por reentrada.
Paciente en buenas condiciones generales, afebril, hemodinamia estable, con necesidad de broncodilatación, posteriormente sin apremio ventilatorio.

En cuanto a lo fonoaudiológico logra ingesta consistencia papilla, sin embargo con limitación para líquidos claros por lo que se decide mantener SNG con plan de retiro en corto plazo según evolución. Considerando temporalidad del evento, inicio de tratamiento, seguridad para régimen papilla, y posibilidad de Hospitalización domiciliaria. Se acuerda en conjunto seguimiento por HODOM.

INDICACIONES AL ALTA

1. Reposo relativo Levantar en forma diaria y pasar a sillón.
2. Régimen mixto papilla hiposódica. Fraccionado, lento, bien despierto y bien sentado. Mantener sentado por 20 minutos posterior
3. Agua 250cc por 4 veces por SNG
4. Aseo cavidad oral por 3 veces.
5. Aspirina 100 mg, 1 comp al día, vía oral.
6. Clopidogrel 75 mg, 1 cop al día, vía oral.
7. Atorvastatina 40 mg, 2 comp por noche, vía oral.
8. Famotidina 40 mg, 1 comp al día, vía oral.
9. Carvedilol 6,25 mg cada 12 horas, vía oral.
10. Fluticasona/Salmeterol 2 puff cada 12 horas, con aerocámara
11. B Ipratropio 2 puff cada 6 horas, con aerocámara.
12. Insulina NPH 10UAM - 6 UPM, subcutanea.
13. Aseo cavidad oral 3 veces a día con Clorhexidina
14. Amoxicilina/Clavulanato 875/125 1 cada 12 horas por 5 días.
15. Kinesioterapia motora
16. Terapia fonoaudiológica
17. Pendiente realización de Holter de ritmo y ecocardiograma
18. Control GES ACV en CAE
19. Control en servicio de urgencias en caso de necesidad. Se explican situaciones de reconsulta.

EXÁMENES Y RESULTADOS

- 30/10/23 Creat 1.1, MDRD 66.7, Uremia 48, BUN 22, ELP 139/4.3/99, PCR 17.9. TSH 5.13, T4L 0.86. VitB12 223. VitD 16.2. HbA1c 6.7. RPR no reactivo.
- 27/10/23 TC de torax: sin foco de condensación. Enfisema centrilobulillar. Engrosamineto intersticial. Banda atelectásica. Cardiomegalia.
- 26/10/23 AngioTC de cerebro y cuello: intensa microangiopatía, con lesión secuelar corona radiada derecha antigua, territorio lenticulo-estriada derecha. Hipodensidad de aspecto reciente periventricular izquierdo. En fase angiográfica con ateromatosis intracraneana difusa, estenosis suboclusiva de segmento M1 izquierdo y oclusivo posterior derecha. Con estenosis significativa bulbo carotideo derecho.
- 26/10/23 Glic 113, Creat 1.0, MDRD 74, Uremia 33, BUN 15, ELP 143/4.5/101, Hb 15.3, Hto 46.8, Leuco 10800, Plaq 402.000, VHS 33, PCR 21.8. P Hepático normal. INR 1.11. TTPa 29. Tropo 10.3, ColT 160, HDL 38, LDL 66, TGL 282. OC no inflamatoria y UC negativo.

OBSERVACIONES:

Ex neurológico:
- Mental: Vigil, nomina 0/3, repite 2/3, sigue ordenes de 1 comando en forma consistente. Disartria moderada
- PC: pupilas isocóricas, RFM +/+, CV conservado, OCM normal sin nistagmus, sensibilidad facial simétrica, PFC derecha. Resto no evaluable
- Motor: Hemiparesia derecha braquial M1, crural M2. Plantar extensor bilateral.
- Sensitivo: sensibilidad algésica conservada
- Cerebelo: no evaluable
- Signos meníngeos negativos.

Christian Alejandro Norambuena Aguayo
MEDICO TRATANTE
16447719-3

JEFE SERVICIO